

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT

刘小华(男)

项目号 M022430002

单位 上海蓝极文化传播有限公司

联系电话 186****6867

项目简称 蓝极文化

员工号

类别 员工

卡号 0010900210628502

部门

递送地址

递送方式 电子报告

体检号 8120240428088



上海爱康国宾名门门诊部

检查日期 2024.04.28

47/2191

爱康国宾®

360°健康全管理

爱康集团是中国领先的中高端连锁体检与健康管理集团，通过旗下多个品牌，为团体客户和家庭、个人提供高品质的健康体检、疾病检测、齿科服务、私人医生、职场医疗、疫苗接种、抗衰老等健康管理及医疗服务。截止2022年8月，爱康集团（包括并购基金）已在59大城市设有155家体检与医疗中心。同时爱康集团与全国200多个城市超过800家医疗机构建立合作网络。

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有



扫码下载爱康APP

www.ikang.com

目录

CONTENTS

1	体检重要异常结果、复查建议及治疗建议	04
	异常情况、专家建议与指导、标准治疗方案	
2	专家建议与指导	05
	建议与指导	
3	健康体检结果	07
	检查详细结果	
4	历年主要异常指标对比	17
	历年数据对比及健康预测	
5	深度咨询或风险评估产品建议	19
	历年指标变化疾病风险评估	
6	医学名词科普知识	20
	医学名词科普知识内容	

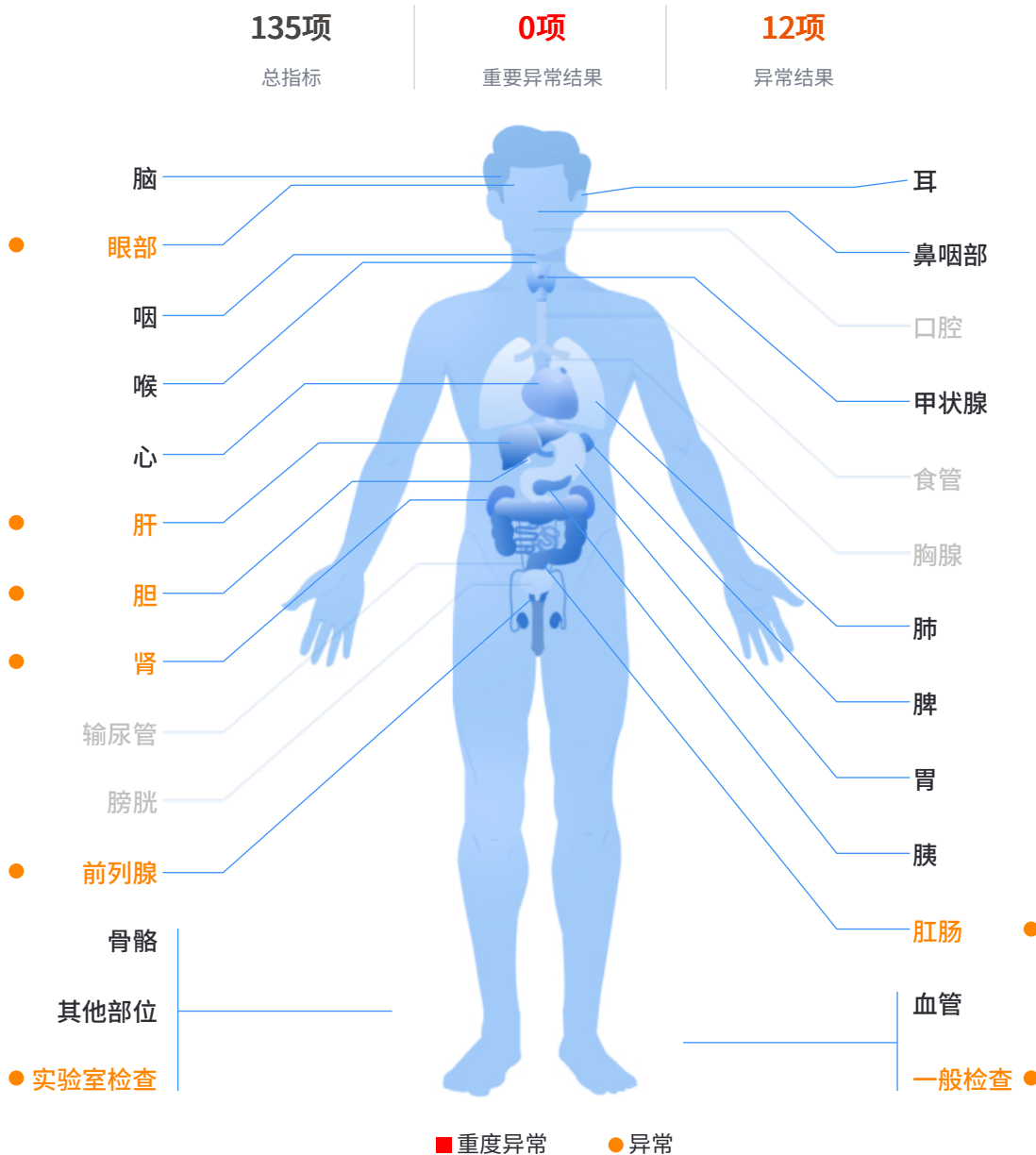
尊敬的刘小华先生，您好！

上海爱康国宾名门门诊部感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2024年04月28日的体检报告呈上。

报告阅读说明书

1. 您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。
2. 健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。
3. 您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。
4. 因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。
5. 由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

体检重要异常结果图示



1. 体检重要异常结果、复查建议及治疗建议

阳性结果和异常情况

- 【1】 体重指数增高
- 【2】 轻度脂肪肝
- 【3】 肝内钙化灶
- 【4】 肝囊肿
- 【5】 胆囊息肉样病变
- 【6】 γ -谷氨酰转移酶增高
- 【7】 左肾结晶；右肾结石
- 【8】 前列腺增生伴钙化灶
- 【9】 内痔
- 【10】 近视眼底改变；屈光不正



下载爱康APP
查看彩色报告

2. 专家建议与指导

01 体重指数增高

- 1、体重指数（体重(kg)÷身高(m)的平方）≥24为超重，≥28为肥胖。
- 2、饮食宜低脂肪、低糖、低盐，控制主食量，辅以适量优质蛋白（鱼、蛋、奶类等）以及各种蔬菜。
- 3、加强运动消耗多余脂肪。可依年龄及身体状况，选择适合自己的运动方式和运动时间，以达到减轻体重的目的。
- 4、推荐运动三要素，频率：每周至少三次；强度：心率达到（170-年龄）次/分；时间：平均每次半小时以上。运动以微汗为宜。

02 轻度脂肪肝

- 1、是肝细胞中脂肪沉着蓄积超过生理含量，程度较轻。
- 2、加强体育锻炼，如：跑步、散步、健美操、打太极拳等，促进脂质代谢。
- 3、建议定期复查，如有肝功能异常消化内科就诊治疗。

03 肝内钙化灶

- 1、肝内钙化灶是指在B超或CT检查图像上出现类似于结石样的强回声光点光斑或光团，多为单个病灶，肝内钙化灶可能与先天发育有关，也可能继发于肝炎后或者是寄生虫感染、肝脓肿、肝脏的良恶性肿瘤以及肝转移瘤中。
- 2、钙化灶多发或有症状，应到肝胆外科专科咨询、完善相关检查，进一步明确病因。

04 肝囊肿

肝囊肿（单发或多发）。随年龄增长检出率亦增加，如无症状,建议定期复查。若直径大于50毫米，或有症状者、逐渐增大者等，请及时专科诊治。

05 胆囊息肉样病变

- 1、是指来源于胆囊粘膜凸入胆囊腔内的突起性病变，它既包含胆囊的炎症性或代谢性增生疾病，也包含胆囊良、恶性肿瘤。
- 2、建议进一步检查明确诊断。

06 γ-谷氨酰转移酶增高

- 1、肝胆疾病可以引起γ-谷氨酰转移酶增高，此外，γ-谷氨酰转移酶对酒精敏感。
- 2、建议复查，如持续增高，请到消化内科诊治。

07 左肾结晶；右肾结石

肾结晶是肾结石形成的前期。注意平时多喝水，保持尿量，减少高草酸食物摄入，尤其是运动后及时补充液体，以防止尿液浓缩形成肾（结晶）结石或使原有（结晶）结石进一步增大。较大的结石可能会引起绞痛或肾盂积水，请及时到泌尿外科就诊。

08 前列腺增生伴钙化灶

- 1、前列腺增生伴钙化是前列腺肥大增生同时内部有钙化灶或者钙化斑。
- 2、前列腺增生又称前列腺肥大，多见中老年男性，年龄的增长是前列腺增生发病的一个重要因素，与



下载爱康APP
查看彩色报告

高脂饮食、饮酒、吸烟及久坐少运动等因素有关。前列腺增生伴钙化灶，钙化灶多是由于以前有过前列腺炎症，愈合后留下钙化斑。

3、建议（1）尽量避免长时间憋尿。（2）减少久坐时间。（3）保持大便通畅。（4）限酒等，预防前列腺增生症状的加重。（5）若出现排尿费力、不畅等症状，应及时医院治疗，预防尿潴留、膀胱结石等并发症的发生。

09 内痔

建议用富含高纤维素膳食，忌食辛辣、忌饮酒，保持大便通畅；养成定时排便习惯，做提肛运动锻炼；注意局部卫生，避免诱发因素引发炎症和便血。必要时请专科诊治。

10 近视眼底改变；屈光不正

多见于轴性近视，注意用眼卫生，眼科随访。

3. 健康体检结果

一般检查室

检查者：陈静

检查项目	测量结果	单位	异常描述	参考区间
身高	175.5	cm		
体重	77.2	Kg		
体重指数	25.1		↑	18.5—23.99
收缩压	112	mmHg		90.0—139.0
舒张压	72	mmHg		60.0—89.0

初步意见 体重指数增高

内科

检查者：刘国庆

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率	68	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	

初步意见 未见明显异常

外科

检查者：杨国祥

检查项目	检查所见	单位
------	------	----



下载爱康APP
查看彩色报告

皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	未见明显异常	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
外生殖器	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	肛内齿状线以上扪及曲张静脉团块	
前列腺(外科)	未见明显异常	
外科其它	无	

初步意见

内痔

眼科

检查者：俞力、邹新莲

检查项目	检查所见	单位
裸视力(右)		
裸视力(左)		
矫正视力(右)	0.8	
矫正视力(左)	0.8	
色觉	正常	
外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	
裂隙灯检查	未见明显异常	
眼底镜检查	双视乳头颞侧弧形斑	

初步意见

1.近视眼底改变
2.屈光不正

耳鼻咽喉科

检查者：赵福香

检查项目	检查所见	单位
既往史	无特殊	
外耳	未见明显异常	
外耳道	未见明显异常	
鼓膜	未见明显异常	
鼻腔	未见明显异常	
鼻中隔	未见明显异常	
咽	未见明显异常	
扁桃体	未见明显异常	
耳鼻咽喉科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

血常规

操作者：张菊红 审核者：陈忠国

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
白细胞计数	WBC	6.20		3.5—9.5	10 ⁹ /L	本院	血	
红细胞计数	RBC	5.53		4.3—5.8	10 ¹² /L	本院	血	
血红蛋白	Hb	165.0		130—175	g/L	本院	血	
红细胞比容	HCT	0.48		0.4—0.5	L/L	本院	血	
平均红细胞体积	MCV	87.0		82—100	fL	本院	血	
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	30		27—34	pg	本院	血	
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	343.0		316—354	g/L	本院	血	
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	12.0		10—20	%CV	本院	血	
血小板计数	PLT	198		125—350	10 ⁹ /L	本院	血	

平均血小板体积	MPV	8.2		4—10	fL	本院	血	
血小板分布宽度	PDW	14.8		10—20	fL	本院	血	
淋巴细胞百分比	LYMPH%	22.70		20—50	%	本院	血	
中性粒细胞百分比	NEUT%	68.2		40—75	%	本院	血	
淋巴细胞绝对值	LYMPH	1.4		1.1—3.2		本院	血	
中性粒细胞绝对值	NEUT	4.2		1.8—6.3		本院	血	
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	41.76		30—54	g/L	本院	血	
血小板压积	PCT	0.16		0.05—1	%	本院	血	
单核细胞百分比	MONO%	7.1		3—10	%	本院	血	
单核细胞绝对值	MONO	0.4		0.1—0.6		本院	血	
嗜酸性细胞百分比	EOS%	1.9		0.4—8.0	%	本院	血	
嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.12		0.02—0.52		本院	血	
嗜碱性细胞百分比	BASO%	0.1		0—1.0	%	本院	血	
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.01		0—0.06		本院	血	

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

尿常规

操作者：张菊红 审核者：杨金民

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
尿比重	SG	1.020		1.010—1.025		本院	尿液	
尿酸碱度	PH	6.5		4.5—8.0		本院	尿液	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	Cell/uL	本院	尿液	
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性		本院	尿液	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	g/L	本院	尿液	
尿糖	GLU	阴性		阴性	mmol/L	本院	尿液	

尿酮体	KET	阴性		阴性	mmol/L	本院	尿液	
尿胆原	URO	阴性		阴性	umol/L	本院	尿液	
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	umol/L	本院	尿液	
尿隐血	BLD	阴性		阴性	Cell/uL	本院	尿液	
尿镜检红细胞	RBC	0		0—3	/HP	本院	尿液	
尿镜检白细胞	WBC	0		0—5	/HP	本院	尿液	
管型	CAST	0		0	个/LP	本院	尿液	
尿液透明度	UCI	清		清		本院	尿液	
尿液颜色	Colour	淡黄		淡黄		本院	尿液	
尿液其它		无				本院	尿液	

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

便隐血

操作者：张菊红 审核者：杨金民

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
便隐血	OB	阴性		阴性		本院	粪便	

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

实验室检查

操作者：罗垚垚 白文 蔡云 张耀 王思雨 胡文芳 审核者：邵琰婕 陈忠国 翟红礼 刘芳 李黎明 刘波

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
人纤维蛋白原降解产物(DR-70)	DR-70	10.30		0—15	ug/mL	上海金域医学检验所	血	

丙氨酸氨基转移酶	ALT	42		0—50	U/L	上海金域医学检验所	血	
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	25		0—40	U/L	上海金域医学检验所	血	
γ-谷氨酰转移酶	GGT	92	↑	10—60	U/L	上海金域医学检验所	血	
碱性磷酸酶	ALP	70		45—125	U/L	上海金域医学检验所	血	
总胆红素	TBIL	15.2		0—26	umol/L	上海金域医学检验所	血	
直接胆红素	DBIL	4.5		0—10	umol/L	上海金域医学检验所	血	
间接胆红素	IBIL	10.7		0—14	umol/L	上海金域医学检验所	血	
总蛋白	TP	69		60—85	g/L	上海金域医学检验所	血	
白蛋白	ALB	48		40—55	g/L	上海金域医学检验所	血	
球蛋白	GLb	21		20—40	g/L	上海金域医学检验所	血	
白蛋白/球蛋白比值	A/G	2.29		1.2—2.4		上海金域医学检验所	血	
尿素	UREA	5.3		3.1—8.0	mmol/L	上海金域医学检验所	血	

肌酐	Cr	66		57—97	umol/L	上海金域医学检验所	血	
尿酸	UA	325		210—420	umol/L	上海金域医学检验所	血	
空腹血葡萄糖	FBG	5.31		3.9—6.1	mmol/L	上海金域医学检验所	血	
总胆固醇	TC	4.42		0—5.2	mmol/L	上海金域医学检验所	血	
甘油三酯	TG	1.40		0.45—1.7	mmol/L	上海金域医学检验所	血	
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.25		0.8—1.8	mmol/L	上海金域医学检验所	血	
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	2.39		0—3.37	mmol/L	上海金域医学检验所	血	
全血粘度1		14.37		9.5—15.2	mPa.s	本院	血	
全血粘度5		9.65		6.91—9.92	mPa.s	本院	血	
全血粘度30		6.76		5.1—6.8	s	本院	血	
全血粘度200		5.68		4.2—5.7	s	本院	血	
血浆粘度	P Visc.	1.75		1.24—1.88	mpas	本院	血	
血沉	ESR	4.00		0—15	mm/h	本院	血	
压积	HCT	0.49		0.38—0.49	L/L	本院	血	
全血高切相对指数		3.25		2.23—4.6	BR	本院	血	
全血低切相对指数		8.21		5.05—12.26	Br	本院	血	
血沉方程K值	ESR-FK	19.38		0—77.66	ESR.K	本院	血	
红细胞聚集指数	Agrbc	1.92		1.34—2.69	Agrbc	本院	血	

全血低切还原粘度		14.80		8.27—29.63	mPa.s	本院	血	
全血高切还原粘度		4.61		2.52—9.47	mPa.s	本院	血	
红细胞刚性指数	IR	4.61		2.51—9.47	IR	本院	血	
红细胞变形指数	TK	0.77		0.46—1.12	TK	本院	血	
幽门螺杆菌抗体	Hp-Ab	1.7		0—15	AU/mL	上海金域医学检验所	血	
甲胎蛋白定量	AFP	2.66		0—13	ng/ml	上海金域医学检验所	血	
癌胚抗原定量	CEA	2.16		0—5	ng/ml	上海金域医学检验所	血	
总前列腺特异性抗原	T-PSA	1.37		0—4	ng/mL	上海金域医学检验所	血	
糖类抗原19-9	CA19-9	2.90		0—40	U/mL	上海金域医学检验所	血	
三碘甲状腺原氨酸	T3	1.33		0.6—1.81	ng/ml	上海金域医学检验所	血	
甲状腺素	T4	8.10		1.9—13.3	ug/dL	上海金域医学检验所	血	
促甲状腺激素	TSH	1.66		0.55—4.78	uIU/mL	上海金域医学检验所	血	

小结

γ-谷氨酰转移酶增高

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

心电图室

检查者：周晓霞

检查项目	检查所见	单位
------	------	----

心电图	窦性心律，心率60~100次/分，P波、P-R间期、QRS波群、ST段、T波、电轴、电压等系列指标参数，均在正常范畴内。	
-----	--	--

初步意见	未见明显异常	
------	--------	--

超声检查室

检查者：扬威

检查项目	检查所见	单位
肝	1.肝脏形态大小正常，肝内实质回声细腻，分布欠均匀，血管纹理走行清晰，门静脉正常。CDFI:血流显示正常 2.肝内可见强回声伴声影 3.肝内可见无回声区，边界清楚，最大约12mm×10mm	
胆	胆囊形态大小正常，胆囊壁可见偏强回声，最大约5mm×4mm，后方无声影，胆汁充盈尚可，胆总管内径正常	
胰	胰腺形态大小正常，内部回声分布均匀，主胰管未见扩张.CDFI:血流显示正常	
脾	脾脏形态大小正常，包膜完整光滑，内部回声分布均匀，脾门血管正常	
双肾	1.左肾集合系统内见点状强回声伴彗星状声影 2.右肾可见强回声伴声影,大小约6mm×4mm	
前列腺	前列腺大小约为46mm×36mm×32mm，体积增大，形态欠规则，内部回声欠均匀，内可见点状强回声	
甲状腺	甲状腺形态大小正常，表面光滑，包膜完整，内部回声均匀。CDFI：血流显示正常。	
颈动脉	颈动脉未见明显异常	

初步意见	1.左肾结晶 2.右肾结石 3.肝内钙化灶 4.轻度脂肪肝 5.肝囊肿 6.胆囊息肉样病变 7.前列腺增生伴钙化灶
------	---

骨密度检查

此项目您已同意放弃检查，本次报告将不包含此检查结果。

胸部正位(iKangAI+)

此项目您已同意放弃检查，本次报告将不包含此检查结果。

颈椎侧位

此项目您已同意放弃检查，本次报告将不包含此检查结果。

评审医师：宣晓明

主检医师：





想随时随地看报告？
想对比您的历史体检报告？
爱康APP，检前检后全管理

约体检

查报告

历史数据对比

专家解读

三甲医院挂号

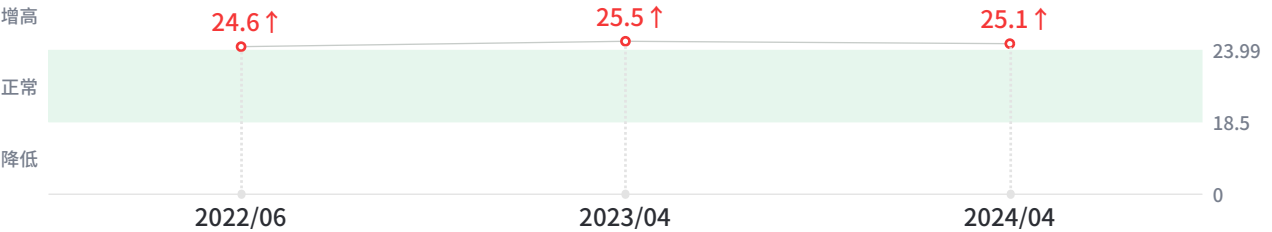
扫码下载爱康APP

iKangCare+ 有人管的体检

4.历年主要异常指标对比

体重指数

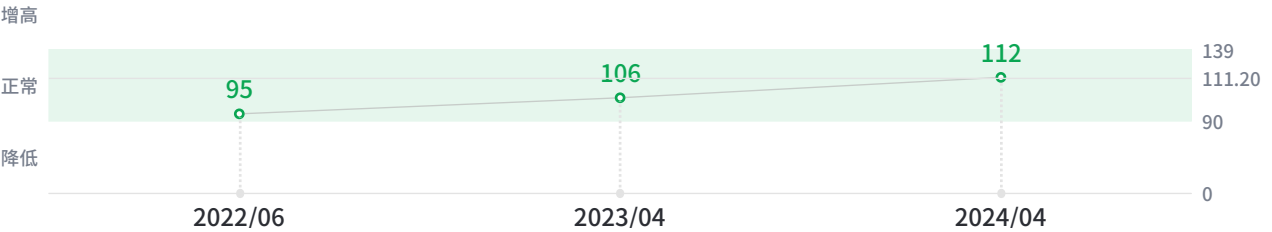
2022年到2024年对比图



年份	测量结果	单位	参考区间
2022/06	24.6		18.5-23.99
2023/04	25.5		18.5-23.99
2024/04	25.1		18.5-23.99

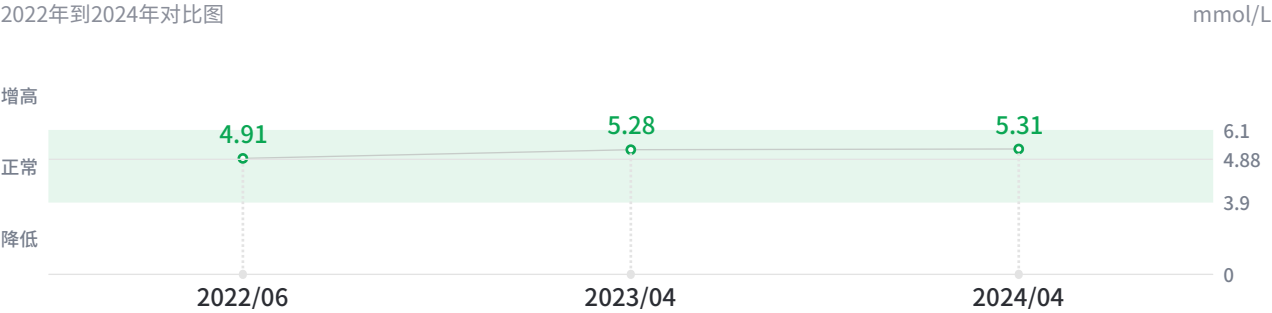
收缩压

2022年到2024年对比图



年份	测量结果	单位	参考区间
2022/06	95	mmHg	90.0-139.0
2023/04	106	mmHg	90.0-139.0
2024/04	112	mmHg	90.0-139.0

空腹血葡萄糖



年份	测量结果	单位	参考区间
2022/06	4.91	mmol/L	3.9-6.1
2023/04	5.28	mmol/L	3.9-6.1
2024/04	5.31	mmol/L	3.9-6.1

5.深度咨询或风险评估产品建议

甘预-肝癌早期筛查

肝癌，一般是指原发性肝细胞癌，约占全部原发性肝癌的85-90%，是最常见的恶性肿瘤之一[1]。2020年世界卫生组织最新数据显示，我国肝癌年新发病例约占全球的45.3%，肝癌年死亡病例约占全球的47.1% [2]。

肝癌高居我国癌症死因的第二位，其发生和发展一般会经历一个漫长的过程。由于早期肝癌无明显痛感，早期发现将有助于肝癌的诊断和治疗。

甘预——肝癌全维度超早期筛查管理方案，能够在无症状期发现3cm以下的肿瘤，为有需求的患者提供覆盖全国多家名牌医院的诊疗绿色通道，使患者能够获得及早诊治机会，5年生存率有效提升至80%以上。

甘预所采用的无创液态活检技术，我国首个获得美国FDA“突破性医疗器械”认定的肝癌早期筛查产品，能够比常见的影像学及血清标志物检测更早期发现癌变，该技术获得了权威指南和共识的推荐[3,4]，并建议您每隔6-12个月进行1次检查。（注：对于罹患肝癌的患者，建议前往医院就诊）

参考文献：

[1] Grandhi MS, Kim AK, Ronnekleiv-Kelly SM, et al. Hepatocellular carcinoma: From diagnosis to treatment. Surg Oncol. 2016;25(2):74-85.

[2] Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021 May;71(3):209-249.

[3] 原发性肝癌诊疗规范（2019年版）[J].传染病信息,2020,33(06):481-500.

[4] 陆荫英,赵海涛,程家敏,姬峻芳.肝胆肿瘤分子诊断临床应用专家共识[J].临床肝胆病杂志,2020,36(07):1482-1488.



甘预

爱康关爱您的肝脏健康

扫描右侧二维码购买



扫码购买

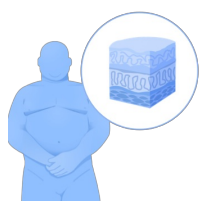


下载爱康APP
查看彩色报告

6.医学名词科普知识

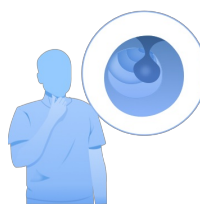
医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

什么是体重指数？



目前常用的体重指数（body mass Index）简称BMI，又译为体质指数。在判断肥胖程度时，使用这个指标的目的在于消除不同身高对体重指数的影响，以便于人群或个体间比较。研究表明，大多数个体的体重指数与身体脂肪的百分含量有明显的相关性，能较好地反映机体的肥胖程度。但在具体应用时还应考虑到其局限性，如对肌肉很发达的运动员或有水肿的病人，体重指数值可能过高估计其肥胖程度。老年人的肌肉组织与其脂肪组织相比，肌肉组织的减少较多，计算的体重指数值可能过低估计其肥胖程度。相等BMI值的女性的体脂百分含量一般大于男性。同时测定体脂百分含量（体脂%）会有助于判断肥胖程度。

什么是息肉？



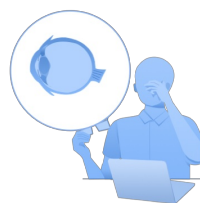
在致炎因子或某种其他因素长期刺激下，局部粘膜上皮、腺体及肉芽组织增生形成。一般发生在消化道、呼吸道、泌尿道等腔道器官内。它自粘膜表面向管腔内突出形成肉样肿块。息肉大小不等，表面光滑，一般无乳头生成，有的可伴有水肿、继发感染和溃疡形成。按发生原因，息肉可分为增生性和腺瘤性两类。增生性息肉又称炎性息肉，即通称的“息肉”。腺瘤性息肉可为新生的肿瘤，多属良性。

什么是γ-谷氨酰转氨酶？



γ - 谷氨酰转氨酶（γ - GT）是谷氨酰循环的重要酶系之一，参与氨基酸的吸收、转运及利用等。由于γ - GT主要来源肝脏，因此γ - GT活性升高是诊断肝脏疾病生化指标之一。在心血管疾病中测定γ - GT活性变化，主要用于判断急性心肌梗死（AMI）后梗死部位心肌修复情况，以及对心功能不全的诊断等。

什么是屈光不正？

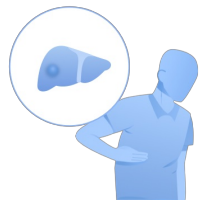


在调节松弛的状态下，正视状态的眼球（正常屈光），入射光线经过角膜、晶状体后聚焦于视网膜表面，形成清晰的图像传入大脑。晶状体具有弹性，年轻人的弹性更好。调节时，睫状肌调整晶状体形状以更好的聚焦影像。屈光不正是指眼在调节松弛的状态下，平行光线经过眼的屈光系统屈折后，不能把光线聚焦成清晰的图像在视网膜上，而成像于视网膜前或后，造成眼视物模糊。屈光不正包括远视、近视和散光。屈光不正的主要症状为视远和（或）视近时视物模糊。有时候，睫状肌张力过高可能引起头痛症状。偶尔，长时间注视可能导致眼表面干燥，引起眼部刺激症状、眼痒、视觉疲劳、异物感和眼红。儿童表现为阅读时皱眉和过度眨眼或者揉眼。矫治近视眼需配戴合适度数的凹透镜，使平行光线在进入眼以前发散，经眼屈光系统后聚焦于视网膜上。同理，矫治远视眼需配戴合适度数的凸透镜，矫治散光需配戴柱镜或球柱镜。散光眼即使度数很轻，若有视力下降，或出现视疲劳症状者，都应当配戴矫正眼镜。对于高度散光眼或不规则散光眼，当镜片无法矫治时可以考虑配戴硬性接触镜或行准分子激光手术治疗。



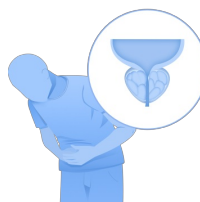
下载爱康APP
查看彩色报告

■ 什么是肝囊肿？



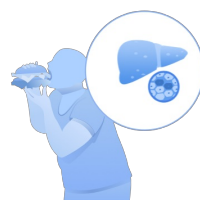
由各种致病因素使肝脏出现囊性病变的一组疾病，是一种较常见的肝脏良性疾病。可分为寄生虫性或非寄生虫性肝囊肿。前者以肝包虫病为多见；后者可分为先天性、创伤性、炎症性及肿瘤性囊肿，以先天性肝囊肿为多见。狭义肝囊肿指先天性肝囊肿，起源于肝内迷走的胆管。临床上可分为单发性肝囊肿和多发性肝囊肿，病程缓慢，可出现肝区胀痛、不适及压迫症状，如黄疸、肠梗阻等。B超是首选检查方法，CT也有助诊断。一般无症状或囊肿较小者无须手术治疗；囊肿较大或出现压迫表现应给予适当的治疗，手术方法有囊肿穿刺抽液术、囊肿开窗术、囊肿引流术或切除术等。

■ 什么是前列腺增生？



前列腺增生（也称前列腺肥大）是男性的常见多发病，好发于40岁后。医学统计显示，我国男性前列腺增生按年龄段划分发病率：50~59岁的发病率为59.8%；60~69岁的发病率为61.8%；70~79岁的发病率为73.9%；80~89岁者发病率为84.2%。年龄越大发病率越高，这是前列腺增生的发病规律。前列腺增生的早期，腺体虽然已经开始增生，但尚未影响到排尿，患者自己不知道，往往在健康体检时才发现，如继续发展或治疗不当，可并发下尿路梗阻，肾、输尿管、膀胱均可受累，甚至发展为尿毒症。前列腺增生是一种渐进性的泌尿生殖系统的良性疾病，导致不同程度的膀胱流出道梗阻症状：尿频、尿急、夜尿、排尿踌躇、出现排空不完全的感觉、尿末淋漓、充盈性尿失禁或完全尿潴留。治疗前列腺增生的方法很多，有药物保守治疗和手术治疗：药物治疗不能根治，只能维持现状，花费高，治疗时间长；手术治疗（包括开放性手术切除、腔内电切、激光、汽化等），疗效虽好，但有时会出现并发症。物理疗法（包括射频治疗、微波治疗、超声聚焦、 β 射线腔内治疗），需多次治疗。

■ 什么是脂肪肝？

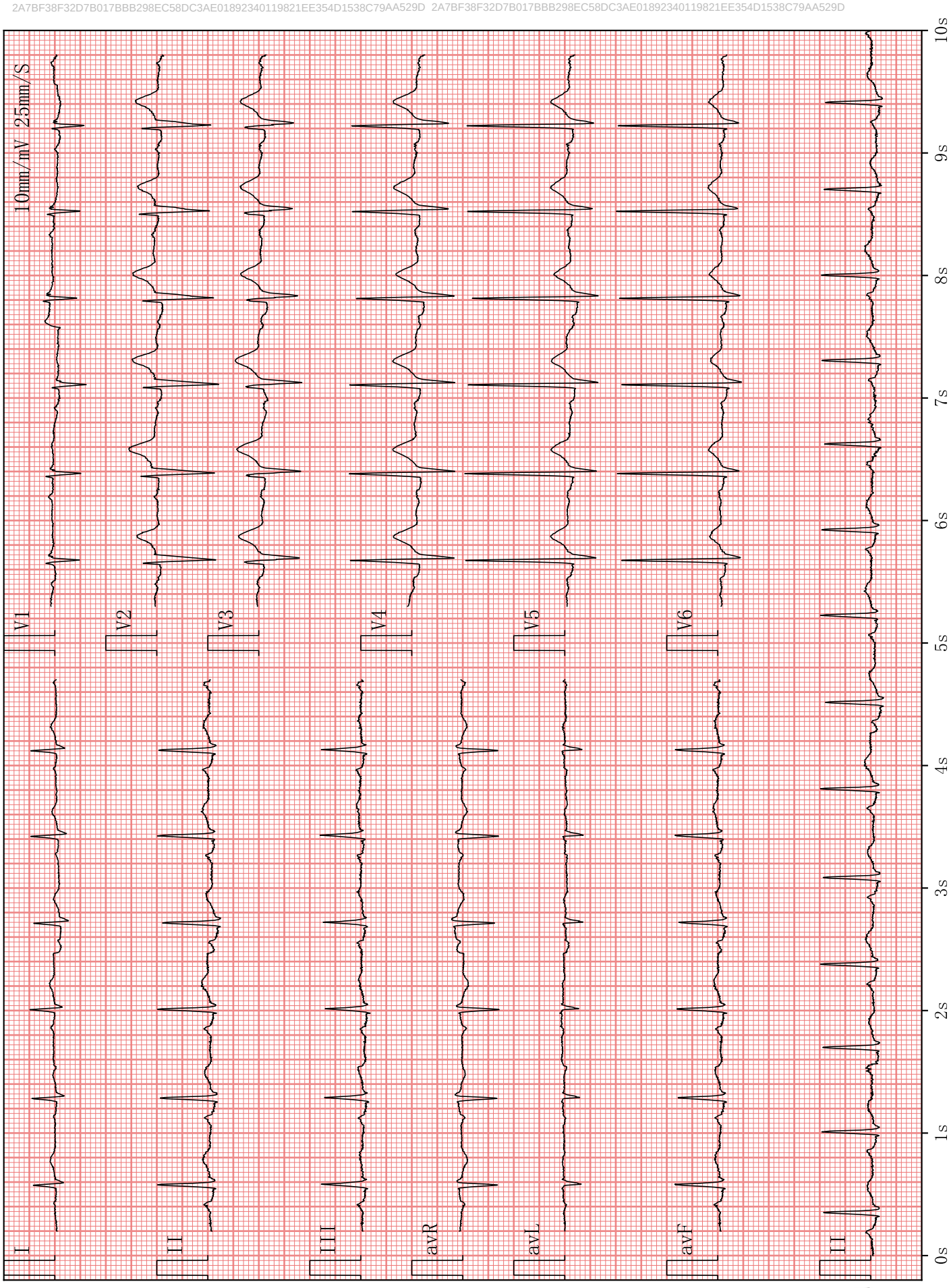


指肝脏内脂肪含量增多，过度充积于肝细胞内超过正常范围。脂肪充盈于肝细胞内可减弱其功能，易受亲肝性毒物所损害，甚至发展为肝硬化。脂肪肝为可逆性，在合理治疗后可恢复正常。因此早期诊断有重要临床意义。大多数脂肪肝患者没有症状。有些患者可感觉疲劳、不适或右上腹不适。B超、CT有辅助诊断意义，确诊必须依靠肝活检。脂肪肝形成原因包括饮食不当、长期大量饮酒、过度肥胖等。防治脂肪肝主要靠调整饮食习惯和结构。

体检号:8120240428088

客户信息:刘小华/男/47

HR:86bpm PR:0.184s QTc:389 RV5/SV1:2.345mV/0.61mV
RR:0.697s QT:0.346s R+S:2.955 P/QRS/T轴:70°/71°/59°



检查者

吉晓霞